

HIV/AIDS — CD4, IO E TARV

CLASSIFICAÇÃO E URGÊNCIA — HIV/AIDS

QUANDO SUSPEITAR DE IO

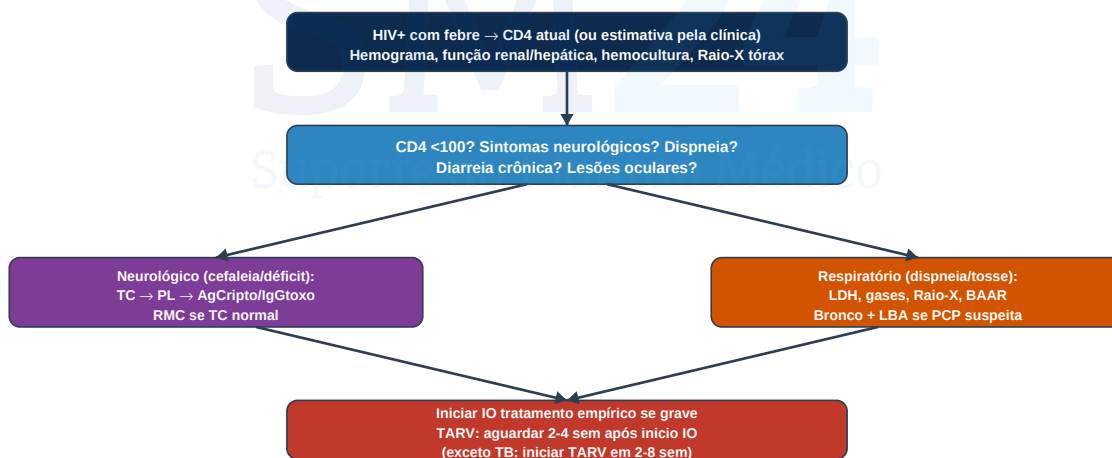
- AIDS: CD4 <200 células/mm³ OU doença definidora de AIDS (IO, neoplasias)
- IO mais frequentes por CD4: >200 (TB, herpes zoster), 100-200 (PCP, toxoplasma), <100 (CMV, MAC, Cryptococcus, Histoplasma)
- Sinais de alerta no PS: febre + cefaleia (criptococose/toxoplasma), dispneia progressiva (PCP), diarreia crônica
- TARV: não iniciar em sepse grave/IO aguda de imediato — risco de SIRS (2-4 semanas após tratar IO)
- Solicitar: CD4 + carga viral + hemograma + função renal + hepática em todos

PRINCIPAIS IOs — DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

IO	CD4 típico	Apresentação clínica	Diagnóstico	Tratamento
PCP (<i>Pneumocystis jirovecii</i>)	<200	Dispneia insidiosa, tosse seca, febre baixa, SpO2 baixa ao esforço	LDH ↑, PCR, LBA	SMX-TMP 15-20mg/kg/dia IV x 21d + prednisona se PO2 <70
Toxoplasmose cerebral	<100	Déficit focal, cefaleia, febre, lesões anulares TC	TC/RMC: lesões múltiplas; IgG toxo; PCR LCR	Sulfadiazina + pirimetamina + leucovorin x 6 sem
Criptococose meníngea	<100	Cefaleia subaguda, febre, meningite linfocítica	Tinta China, AgCriptococo sérico/LCR	Anfotericina B 0,7-1mg/kg/d + flucitosina x 2 sem → fluconazol
CMV	<50	Retinite (baixa visual), colite (diarreia com sangue), encefalite	Fundoscopia, colono, PCR CMV	Ganciclovir 5mg/kg IV 12/12h x 3-6 sem
TB pulmonar	Qualquer	Tosse, febre vespertina, sudorese, perda de peso	BAAR/GeneXpert, cultura, Raio-X	RIPE 6 meses; TARV 2-8 sem após ATB
Histoplasmose disem.	<150	Febre, adenomegalia, hepatoesplenomegalia, pele	Antígeno urina, hemocultura fúngica	Anfotericina B → itraconazol 200mg 2x/d

ABORDAGEM DO HIV+ COM FEBRE NO PS

HIV + FEBRE — FOCAR NO CD4



PCP — MAIS COMUM EM PS COM CD4 <200

PNEUMOCISTOSE — DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

- Clínica: dispneia insidiosa (dias-semanas), tosse seca não produtiva, febre baixa, queda de SpO2 ao esforço
- Raio-X: infiltrado intersticial bilateral difuso (padrão em 'vidro fosco'); normal em 20%
- LDH: elevado >500 UI/L (marcador de dano celular — alta sensibilidade, baixa especificidade)
- Diagnóstico definitivo: PCR ou imunofluorescência no LBA; raramente necessário no PS
- Tratamento: SMX-TMP 15-20 mg/kg/dia IV (trimeto) em 3-4 doses por 21 dias
- Corticoide: prednisona 40mg 12/12h x 5d → 40mg/d x 5d → 20mg/d x 11d se PO2 <70 mmHg

CRIPTOCOCOSE + TOXOPLASMA — URGÊNCIAS NEUROLÓGICAS

Criptococose Meníngea

- Cefaleia subaguda + febre; rigidez de nuca pode ser leve
- PL: pressão abertura alta, líquido claro, tinta China +
- AntígenoC neoformans sérico/LCR: sensibilidade 99%
- Tratamento: Anfotericina B lipossomal 3-4mg/kg/d + flucitosina x 2 sem
- Consolidação: Fluconazol 400mg/d x 8 semanas
- Drenagem de PL seriada se PIC ≥25 cmH2O (não usar acetazolamida)

Toxoplasmose Cerebral

- Déficit focal + febre + cefaleia em HIV CD4 <100
- TC: lesões anulares múltiplas com edema (75%); RMC mais sensível
- IgG anti-toxoplasma positivo (95% dos casos); PL se possível
- Tratamento: Sulfadiazina 1-1,5g VO 6/6h + Pirimetamina 200mg d1 → 50-75mg/d + Leucovorin 10-20mg/d
- Duração: 6 semanas fase aguda → manutenção
- Dexametasona: apenas se efeito de massa com herniação

PROFILAXIA PRIMÁRIA DAS IOS

QUANDO INICIAR

- ☐ CD4 <200: SMX-TMP 960mg/dia (cobre PCP + Toxoplasma + Isospora) — iniciar com TARV
- ☐ CD4 <100: manter SMX-TMP (cobre toxoplasmose); fluconazol 200mg/d se candidíase recorrente
- ☐ CD4 <50: Azitromicina 1200mg/semana — profilaxia de MAC (Mycobacterium avium complex)
- ☐ Anti-HBV: vacinar todos HIV+ não imunes; anti-CMV: TARV reduz o risco
- ☐ Suspender profilaxias: CD4 >200 por >3 meses com TARV eficaz
- ☐ TARV: sempre indicada em todos os pacientes HIV+ independentemente do CD4

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente HIV+ com CD4 de 80 cels/mm³, cefaleia progressiva há 2 semanas e febre. PL com tinta China positiva. Qual é o tratamento de escolha?

- A) Fluconazol 150mg dose única
- B) Anfotericina B lipossomal 3-4 mg/kg/d + flucitosina por 2 semanas
- C) SMX-TMP IV 15 mg/kg/dia
- D) Sulfadiazina + pirimetamina
- E) Aciclovir 10 mg/kg IV 8/8h

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

HIV+ com CD4 de 150 cels/mm³, dispneia progressiva há 10 dias, tosse seca, febre baixa e LDH de 620 UI/L. Raio-X com infiltrado em vidro fosco bilateral. Qual diagnóstico e tratamento?

- A) Pneumonia bacteriana por *S. pneumoniae* — ceftriaxona + azitromicina
- B) Pneumocistose (PCP) — SMX-TMP 15-20 mg/kg/dia IV por 21 dias + prednisona se PO₂ <70
- C) Tuberculose pulmonar — RIPE
- D) Histoplasmoze — anfotericina B
- E) Criptococose pulmonar — fluconazol

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Quando está indicado iniciar corticoide (prednisona) no tratamento da PCP?

- A) Em todos os casos de PCP confirmada
- B) Apenas se CD4 <50
- C) PO₂ arterial <70 mmHg ou gradiente alveolo-arterial >35 mmHg
- D) Apenas em pacientes com co-infecção com CMV
- E) Corticoide é contraindicado em HIV+

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

HIV+ com CD4 de 60 cels/mm³ e TC mostrando múltiplas lesões cerebrais anulares com edema. IgG anti-toxoplasma positivo. Qual é o tratamento de escolha?

- A) Aciclovir 10 mg/kg IV
- B) Anfotericina B + flucitosina
- C) Sulfadiazina 1g VO 6/6h + Pirimetamina 50 mg/d + Leucovorin
- D) Metronidazol IV
- E) SMX-TMP IV

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Quando deve ser iniciada a TARV em paciente com HIV recém-diagnosticado com tuberculose ativa?

- A) Imediatamente junto ao RIPE
- B) Apenas após completar 6 meses de RIPE
- C) 2-8 semanas após início do tratamento para TB
- D) Aguardar CD4 cair abaixo de 200
- E) Nunca em paciente com TB ativa

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Criptococose meníngea em AIDS: anfotericina B lipossomal 3-4 mg/kg/d + flucitosina 100 mg/kg/d IV por 2 semanas (indução), depois fluconazol 400mg/d por 8 semanas (consolidação). Monitorar PIC — drenagem seriada se >25 cmH₂O.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

PCP: quadro subagudo (10+ dias), dispneia progressiva, tosse seca, febre baixa, LDH elevado, infiltrado bilateral em vidro fosco no Raio-X. CD4 <200 clássico. SMX-TMP 15-20 mg/kg/d IV por 21 dias. Corticoide se PO₂ <70 mmHg.

QUESTÃO 3 → Resposta: C

Prednisona na PCP: indicada quando PO₂ <70 mmHg ou gradiente A-a >35 mmHg — reduz mortalidade e piora respiratória. Esquema: 40mg 2x/d x 5d → 40mg/d x 5d → 20mg/d x 11d. Dar junto ou antes do SMX-TMP.

QUESTÃO 4 → Resposta: C

Toxoplasmose cerebral: sulfadiazina 1-1,5g VO 6/6h + pirimetamina 200mg d1 → 50-75mg/d + leucovorin 10-20mg/d por 6 semanas. Aciclovir não tem atividade contra Toxoplasma. Dexametasona só se herniação por edema.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

HIV + TB: TARV deve ser iniciada 2-8 semanas após início do RIPE (2 semanas se CD4 <50 ; 8 semanas se CD4 >50). Não simultaneamente — risco de SIRI (síndrome inflamatória de reconstituição imune) grave.

SM24
Suporte ao Plantão Médico